

환자 의무 기록지

실습기간	2026년 6월 29일 ~ 7월 3일		
실습임상과	류마티스 내과	조	A-7
학번	202152517	이름	김민지

주요 증상 및 증세		RF 44.8 IU/mL로 협진 의뢰, finger joint arthralgia, dry eye					
환자명	조O옥	연령	72Y	성별	F	병력지번호	160153318

>> Present illness

상환 72세 여환으로 5월 3일 좌측 상공막염으로 응급실 내원하여 시행한 자가항체검사서 FANA/ANCA (-/-)이며, 이후 5월 18일 안과 외래에서 RF 44.8 IU/mL로 확인되어 류마티스 내과 협진 의뢰되어 내원함. 5-6년 전부터 양손 DIP 및 thumb IP 관절 전체에 우리하고 콕콕 쑺시는 통증과 변형 발생함. 통증은 오전에 더 심하고, 손 사용 후에도 악화됨. 5-10분 정도의 조조강직 동반됨. 문진 당시 가벼운 압통 호소하였으나 뚜렷한 열감은 없었음. 방사통도 없음.

3-4년 전부터 매일 안구 건조 증상 있으며, 하루 4-5회 인공눈물 사용 중임. 눈이 자주 충혈되며, 2016년 상공막염으로 안과 추적관찰하다 loss 됨.

타원에서 무릎 OA 진단받고(2.5기) 6개월마다 연골 주사 치료 중임.

>> History

Past Hx.	DM(-)/HTN(-)/Tb(-)/Hepatitis(-)/ Dyslipidemia(+, 10년 전) /Malignancy(-)/골다공증(-) knee OA 우안 공막염 (2016)
Allergy (drug, RCM)	복숭아 알레르기
Operation Hx.	백내장 수술(2025.07), 아킬레스건 수술(2019.09) 충수절제술(60년 전)
Family Hx.	N/S
Medication Hx.	고지혈증 약 Ginkgo leaf dried extract (혈행개선 목적)
Social Hx.	Smoking: (-) Drinking: (-) 현재 주부, 20년 전 식당일 및 식육점일 (3-4년 일함)

>> Review of system (26.06.30)

Skin thickening	-	Dry eye	+
Subcutaneous nodules	-	Red eye	+
Oral ulcer	-	Decreased visual acuity	-
Genital ulcer	-	Dry mouth	-
Malar rash	-	Edema	-
Discoid rash	-	Psoriasis	-
Photosensitivity	-	Neuropathic pain	-
Skin lesion	-	Back pain	-
Nail change	-	Myalgia	+
Dactylitis	-	Epigastric pain	-
Raynaud's phenomenon	-	Hunger pain	-
Cough	-	Dysphagia	-

>> Physical examination (26.06.30)

General	Not so ill looking Ht : 152 cm Wt: 67kg
Vital sign	BP 128/74 mmHg HR 72/min
HEENT	N/S
Neck	N/S
Chest	N/S
Abdomen	N/S
Back & Extremities	edema (-)
Musculoskeletal	Morning stiffness 5-10min 양손 DIP Heberden's node (+) bilateral 2nd DIP deformity Active ROM pain (+) Passive ROM pain (-) SJ/TJ (-/-)
Skin	N/S

>> 감별 진단

R/O Osteoarthritis

R/O Rheumatoid arthritis

>> Diagnostic Plan

1. Evaluation for osteoarthritis (OA)

- Hand X-ray (both)

2. Evaluation for rheumatoid arthritis (RA)

- RF
- Anti-CCP Ab
- ESR, CRP

3. Evaluation for connective tissue disease

- FANA
- Anti-SSA/Ro, Anti-SSB/La
- 필요시 Schirmer test, ocular staining, salivary gland function test, salivary gland biopsy

>> Lab findings

CBC (26.06.30)

항목	수치	기준치	단위
WBC	4.63	3.8~11.0	10E3/uL
RBC	4.05	3.6~5.4	10E6/uL
Hb	12.8	11.2~15.0	g/dL
Platelet	165	140~420	10E3/uL

LFT/RFT (26.06.30)

항목	수치	기준치	단위
AST	28	0~40	U/L
ALT	16	0~40	U/L
ALP	68	35~104	U/L
BUN	19.9	6~26	mg/dL
Creatinine	1.73	0.4~1.2	mg/dL
GFR(CKD-EPI)	82.3		mL/min/1.73m ²

Inflammatory markers (26.06.30)

항목	수치	기준치	단위
ESR	11	0~15	mm/hr
CRP(hs-CRP)	0.04	0~0.5	mg/dL

Autoimmune serologic tests

항목	결과	기준치	단위
R/O Rheumatoid arthritis			
RF 정량	44.8	0~14	IU/mL
Anti-CCP Ab	Negative(1.2)	0.0~5.0	U/mL
R/O Connective tissue disease			
FANA	1:80 미만	1:80 이하	U/mL
Anti-SS A (Anti-Ro)	Negative (0.7)	<7	U/mL
Anti-SS B (Anti-La)	Negative (0.3)	<7	U/mL
R/O ANCA-related vasculitis (26.05.03)			
MPO Ab	Negative(0.6)	<5.0	U/mL
PR-3 Ab	Negative(1.9)	<5.0	U/mL

>> Image finding (26.06.30)

Hand PA both



- joint space narrowing with osteophyte at both DIP and thumb IP → OA 시사
- no evidence of marginal erosion

Hand oblique both



- bony enlargement with osteophyte at both thumb IP and DIP

>> Assessment

1. Chronic noninflammatory arthritis - Osteoarthritis

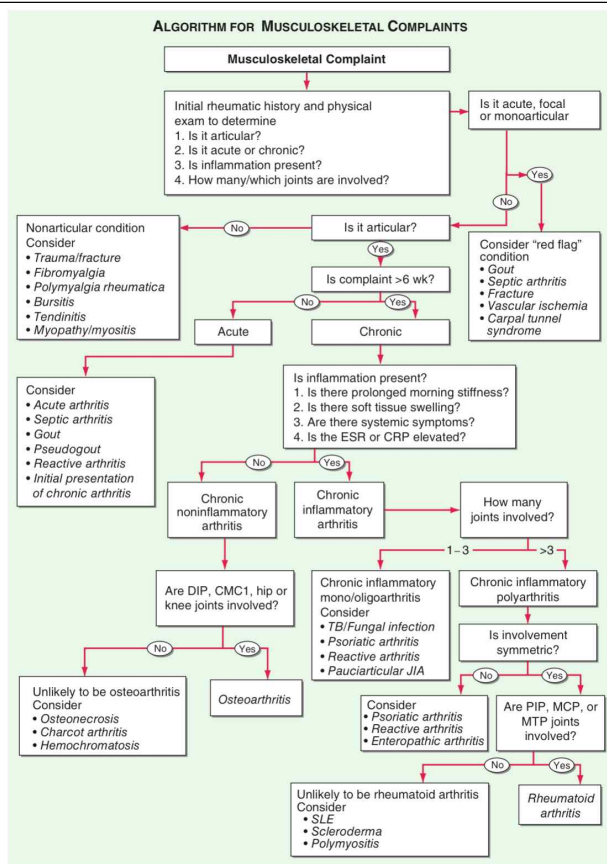


FIGURE 363-1 Algorithm for the diagnosis of musculoskeletal complaints. An approach to formulating a differential diagnosis (shown in italics). CMC, carpometacarpal; CRP, C-reactive protein; DIP, distal interphalangeal; ESR, erythrocyte sedimentation rate; JIA, juvenile idiopathic arthritis; MCP, metacarpophalangeal; MTP, metatarsophalangeal; PMR, polymyalgia rheumatica; SLE, systemic lupus erythematosus.

- Articular : 양측 손가락 관절 중심으로 통증 호소함. 특정 자세 및 위치에서 통증 유발되지는 않음.
- Chronic : 5-6년 전부터 통증 발생함. 육안상 DIP에 Heberden's node, X-ray 상 joint narrowing 및 osteophyte formation 소견도 관찰되어 만성적인 변화를 보여줌.
- Noninflammatory : morning stiffness 5-10분으로 짧음. Swelling은 soft tissue swelling보다 bony enlargement 양상임. 체중감소, 발열 등 전신 증상 없음. ESR, CRP 정상 범위임. 발적 및 열감 뚜렷하지 않음.
- DIP and knee involved
→ 만성 비염증성 관절염 중 osteoarthritis 에 해당

2. Osteoarthritis (1990 ACR classification Criteria for Hand Osteoarthritis)

Pain, aching or stiffness in the hand AND 3 OF THE FOLLOWING Hard tissue enlargement of 2 or more of the following joints: 2nd and 3rd distal interphalangeal, the 2nd and 3rd proximal interphalangeal, and the 1st carpometacarpal joints of both hands Hard tissue enlargement of 2 or more distal interphalangeal joints Less than 3 swollen MCP joints Deformity of at least one of the joints listed above in 1	- 본 환자는 hand pain을 호소하며, 우측 2nd, 4th DIP, 좌측 2nd, 5th DIP을 포함한 여러 부위에서 hard tissue enlargement (골성 비대)인 Heberden's node가 두드러지게 관찰됨. - MCP joints에 swelling 없으며, 양측 2nd DIP와 우측 4th DIP에 lateral deviation 일어난 deformity 관찰됨. - 따라서 OA 진단 기준 충족함.
--	--

3. RA, less likely

- 현재 뚜렷한 swelling, 압통, 열감 등 definite clinical synovitis 시사하는 소견이 관찰되지 않아 만성 염증성 관절염의 가능성 낮음.
- 특히, 2010 ACR/EULAR classification criteria의 entry criterion인 '적어도 하나 이상의 관절에서 definite clinical synovitis 관찰'을 만족하지 않음.
- RF는 high-positive이나, RF는 RA에 특이적인 항체가 아니며, 다른 자가면역질환, 만성 감염 및 고령에서도 양성으로 나타날 수 있음. 특이도가 높은 anti-CCP Ab에서 음성을 보이고, ESR, CRP가 정상임을 고려할 때 RA 가능성 낮음.

4. Chronic dry eye

- 3-4년 전부터 지속된 안구건조로 하루 4-5회 인공눈물 사용 중이나, 구강건조 및 parotid gland enlargement 등 침샘침범을 시사하는 임상 소견 없음.
- Harrison에서 안구건조 and/or 구강건조 또는 주요 침샘 종대 또는 전신증상 있을 경우 Sjögren syndrome을 의심하여 work up 시작할 수 있다고 제시함.
- Anti-SSA/Ro, Anti-SSB/La 및 FANA 음성으로 현재 Sjögren syndrome을 강하게 시사하는 혈청학적 근거는 부족함.
- 다만, Schirmer test, ocular staining, salivary gland function test, salivary gland biopsy 시행하지 않아 Sjögren syndrome을 완전히 배제할 수는 없음.

>> Therapeutic Plan

1. Hand osteoarthritis

Physical management modalities

- 통증 유발 행동 및 반복적 손 사용 피하기

Pharmacotherapy

- OA에 대한 disease-modifying therapy는 없으며, 증상 조절을 목표로 함.
- Topical NSAIDs : 경증 통증일 시 우선 사용. 필요 시에 적용하며, 통증 지속되면 매일 사용 고려
- Oral NSAIDs : topical NSAIDs로 조절되지 않거나 중등도 이상의 통증일 경우 사용. 필요 시 복용으로 조절되지 않을 경우 anti-inflammatory dose로 매일 사용 고려
 - oral NSAIDs 사용 시 위장관, 심혈관 및 신장 부작용 모니터링 필요
 - 위장관 부작용이 발생하거나 위장관 고위험군의 경우 위장관 독성 적은 COX-2 selective NSAID나 PPI 병용 고려
- 필요 시 관절강내 glucocorticoid 주사 : synovitis 동반의 급성 통증 악화 시 사용. 반복 주사는 경미한 연골 소실 가능하여 주의 필요
- Methotrexate 고려 : hand OA에서 통증 감소 효과가 일부 연구에서 보고되었으나, 아직 표준 치료로 확립되지는 않음
- Curcumin : 항염증 효과로 통증 완화에 도움줄 수 있음.
- Opioid는 장기적인 이득이 불명확하며 의존성 위험으로 사용 권고하지 않음

2. RA, less likely

- 현재 RA를 시사하는 definite clinical synovitis 없어 DMARD 치료는 시행하지 않음.
- 추적관찰하고 추후 synovitis 발생하거나 염증성 관절염 시사하는 소견 발생할 경우 재평가 필요

3. Chronic dry eye

- 인공눈물 점안 유지
- 증상 지속 또는 악화 시 안과 추적관찰 및 필요 시 Schirmer test 등 추가 평가 고려

>> References

- Loscalzo J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, eds. Harrison's Principles of Internal Medicine. 22nd ed. McGraw Hill; 2024.
- American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines: Arthritis Rheum 43(9):1905-15, 2000.